

CC Ophtalmo

Si nerf optique est à gauche de la macula = œil gauche

Macula = centre de la rétine, vision 10/10, au centre de la macula on a la fovéa

Vx partent de la papille

Papille = nerf optique avec veines et artères

Questions fondamentales à sortir à tout examen ophtalmo :

Rougeur oculaire

Douleur oculaire

Baisse de vision

Puis : brutal ou progressif, facteur déclenchant (lentilles ? corps étrangers dans l'œil ? prise de médicament ?), date de début des symptômes

ATCD ophtalmo :

- Port de lunette, lentilles de contact, strabisme ? chirurgie récente, infection, trauma, glaucome
- Généraux : DT, HTA, corticoïdes au long cours, etc

Examen ophtalmo :

- Il faut faire lire les patients (ça fait gagner des points)
- Réfraction objective (après avoir mesuré la puissance de l'œil avec le refractomètre) et subjectif c'est avec les lunettes
- Pression oculaire : à air ou à aplanation
- Examiner segment antérieur et fond d'œil

Pour examiner segment antérieur : lampe à fente

Dans la vraie vie, ophtalmoscope est obsolète mais on l'utilise à l'examen

De plus, champ visuel (si AVC) -> savoir faire par confrontation, sinon périmétrie cinétique de Goldman ou dynamique

OCT (tomographie à cohérence optique) -> coupes fines de la rétine -> bien pour dégénérescence maculaire, œdème maculaire du au DT, etc

Si cataracte, hémorragie vitrée importante -> si on voit pas la rétine, il faut parler de échographie oculaire en mode B

En plus : angiographie rétinienne (fluorescéine utilisée pour dépister vx anormaux, par ex ds DT ou occlusion veineuse de la rétine, OACR)

ICG (vert d'indocyanine permet d'analyser la choroïde -> pour uvéite ou dégénérescence maculaire liée à l'âge)

Motifs fréquents :

- Syndrome « cornéen » : rougeur oculaire, photophobie, larmoiement, blépharospasme, douleurs oculaire (brûlures, picotements)
- Att : uvéite antérieure : œil rouge, douloureux et photophobie ++ aussi
- Syndrome « maculaire » : BAV, scotome central ou paracentral, métamorphopsies, micropsies ou macropsies
- Autres : myodésopsies, phosphènes (éclair visuel), diplopie mono ou binoculaire, céphalées

OACR

- BAV brutale, FRCV, œil blanc et indolore, macula rouge cerise, rétine pale et ischémique
- Artères fines et de petit calibre
- Soit lié à Horton soit emboligène

NOIAA

- Neuropathie optique ischémique antérieure aiguë
- BAV brutale, atteinte altitudinale du CV
- Soit Horton (urgence) ou non artéritique (hypoperf du nerf optique\$9

OVCR

- Hémorragies nombreuses au FO, œdème maculaire
- BAV rapidement progressive

DMLA

- Atrophique vs exsudative
- Syndrome maculaire (exsudative) ; BAV avec scotome central si atrophique

Pour tester les couleurs -> tester avec le rouge ou Ishihara

Dans névrite optique

- ➔ On cherche le RAPD : il faut se mettre dans l'obscurité, on fait alternance avec lumière dans les 2 yeux et une pupille va se dilater

Si qq vient pour corps étranger -> il faut retourner la paupière (avec coton-tige) et test à la fluorescéine

Test à la fluorescéine

Tester l'oculomotricité : poursuite et saccades

Saccades ralenties -> problème du nerf oculomoteur

Ophtalmoscope :

Lumière bleue ou verte c'est pour test à la fluorescéine

Il faut être à environ 10cm de l'œil et ensuite se déplacer pour tout explorer